PRODUTO TÉCNICO

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Instrumento de auxílio às equipes na organização do cuidado de crianças com alto risco para TEA ou diagnóstico confirmado



Larissa Cavalcante
Mestranda ProfSaúde · Universidade Federal da Bahia

Orientadora
Profa. Dra. Nilia Prado
Universidade Federal da Bahia

Salvador
2026

◇ Como utilizar este PTS

> Este documento deve ser adaptado à realidade clínica, social, familiar e territorial de cada criança e sua família.

Construção compartilhada

Selecionar e adaptar as habilidades conforme a avaliação funcional individual da criança.

Pactuar as ações considerando as necessidades da criança, as possibilidades da família e os recursos disponíveis no território.

Registrar os responsáveis e a frequência das ações acordadas.

Acompanhar a realização das ações e reorganizar a frequência conforme as demandas e necessidades da família, de forma periódica.

Parte A Construção do cuidado

1, 2 Identificação, motivo da construção do PTS
3, 4 Objetivo geral e habilidades prioritárias
5 e 6 Ações da APS
7 Rede de cuidado
8 Pactuações familiares

Parte B Acompanhamento

9 Monitoramento da equipe
10 Monitoramento das ações pactuadas com a família
11 Monitoramento da rede
12 Observações da família e da equipe

▤ 1 Identificação

Nome da criança: _____

Idade: _____ Data de nascimento: _____

Responsável: _____

Unidade de Saúde: _____

Equipe de referência: _____

Data do PTS: _____

◇ 2 Motivo da construção do PTS

Adaptar conforme necessidades específicas da criança, avaliação funcional e contexto familiar.

Criança com rastreio positivo para alto risco de Transtorno do Espectro Autista pelo M-CHAT-R/F (pontuação _____), apresentando prejuízos/sinais em:

☐ comunicação	☐ interação social
☐ atenção compartilhada	☐ linguagem funcional
☐ brincadeira simbólica	☐ habilidades adaptativas
☐ autonomia nas atividades diárias	☐ comportamento/restrição comportamental
☐ regulação sensorial	☐ interação escolar/socialização

☐ Outro: _____

Necessitando intervenção precoce multiprofissional articulada pela Atenção Primária à Saúde, acompanhamento longitudinal e construção compartilhada do cuidado com a família e rede intersetorial.

◎ 3 Objetivo geral

> Promover desenvolvimento global da criança por meio da aquisição progressiva de habilidades comunicativas, sociais, cognitivas e adaptativas, com cuidado coordenado pela APS.

Os objetivos devem ser individualizados conforme habilidades e necessidades da criança.

◇ 4 Habilidades prioritárias a desenvolver

Selecionar e adaptar conforme avaliação funcional individual da criança.

Comunicação

Responder ao nome, solicitar necessidades, ampliar linguagem funcional

Socialização

Compartilhar atenção, brincar com outras crianças, contato social

Comportamento

Melhor tolerância a mudanças e frustrações

Autonomia

Alimentação, higiene, organização simples

Cognição

Atenção compartilhada, imitação, seguimento de comandos

Sensorial

Melhor adaptação a estímulos ambientais

Outras prioridades

✚ 5 Ações da APS

> As ações devem ser pactuadas conforme disponibilidade da rede e necessidades da família.

Profissional APS	Ações Propostas	Habilidade Trabalhada
Médico(a)	Monitorar desenvolvimento neuropsicomotor e orientar família	Desenvolvimento global
Enfermeiro(a)	Educação em saúde e construção de rotina estruturada	Autonomia
ACS	Reforçar orientações em visita domiciliar	Generalização de habilidades
Psicólogo(a)	Trabalhar interação social e manejo comportamental	Socialização
Fonoaudiólogo(a)	Estimular linguagem funcional	Comunicação

✚ 5 Ações da APS Continuação

As ações devem ser pactuadas conforme disponibilidade da rede e necessidades da família.

Profissional APS	Ações Propostas	Habilidade Trabalhada
Terapeuta Ocupacional	Habilidades funcionais, abordando aspectos sensoriais, motores e cognitivos.	Autonomia e regulação sensorial
Assistente Social	Apoio familiar e acesso à rede	Redução de vulnerabilidades
Cirurgião-dentista	Monitorar saúde bucal, orientar dessensibilização gradual para higiene oral, acompanhar dificuldades sensoriais relacionadas à escovação e alimentação.	Autonomia, regulação sensorial e cuidado em saúde bucal
Nutricionista	Monitorar comportamento alimentar, sinais nutricionais e dificuldades sensoriais; orientar família	Ampliar o repertório alimentar

6 Rede de cuidado

> Adaptar conforme recursos disponíveis no território e serviços acessíveis à família.

ESF — **eMulti/NASF** — **CER**

↕ **CRIANÇA E FAMÍLIA** ↕

CAPSij — **Escola** — **CRAS**

Serviço	Papel
ESF	Coordenação longitudinal
eMulti/NASF	Apoio matricial
CER	Reabilitação
CAPSij	Saúde mental infantil
Escola	Inclusão e socialização
CRAS	Apoio social
Família	Estimulação contínua

↔ 7 Pactuações familiares e participação no cuidado

As pactuações devem respeitar possibilidades, rotina e vulnerabilidades da família.

Necessidade Identificada	Ação Pactuada com a Família	Responsável Familiar	Frequência
Déficit de comunicação	Estimular nomeação de objetos e pedidos simples	_____	
Pouca interação social	Realizar brincadeiras interativas face a face	_____	
Pouca atenção compartilhada	Incentivar apontar e troca de olhar	_____	
Rigidez comportamental	Manter rotina estruturada previsível	_____	
Déficit de autonomia	Incentivar alimentação e higiene com supervisão	_____	
Seletividade alimentar	Oferecer alimentos de forma gradual, sem coerção, manter rotina alimentar estruturada, estimular contato progressivo com novos alimentos e registrar aceitação alimentar.	_____	Diária / acompanhamento periódico

8 Monitoramento das ações da equipe

Ano: _____

Ação	Responsável	Frequência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consulta médica APS	Médico(a)	Mensal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Consulta enfermagem	Enfermeiro(a)	Mensal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Visita domiciliar	ACS	Quinzenal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fonoaudiologia	Fono	Semanal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Terapia ocupacional	TO	Semanal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Psicologia	Psicólogo(a)	Semanal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Orientação familiar	Equipe APS	Contínuo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Articulação com escola	APS	Mensal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

⌂ 8.1 Acompanhamento das ações em casa

Mês: _____

☐ Não realizado/não atingido ☑ Realizado/atingido
⊘ Parcialmente realizado/parcialmente atingido

Necessidade identificada	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Déficit de comunicação	☐	☐	☐	☐
Pouca interação social	☐	☐	☐	☐
Pouca atenção compartilhada	☐	☐	☐	☐
Rigidez comportamental	☐	☐	☐	☐
Déficit de autonomia	☐	☐	☐	☐
Seletividade alimentar	☐	☐	☐	☐
Redução de tempo de tela	☐	☐	☐	☐
Interação verbal/leitura/canções	☐	☐	☐	☐
Interação com outras crianças	☐	☐	☐	☐
Regulação sensorial	☐	☐	☐	☐
Higiene e autocuidado	☐	☐	☐	☐
Rotina estruturada	☐	☐	☐	☐

> Adaptar conforme necessidades da criança, possibilidades familiares e pactuação com a equipe da APS. Reorganizar a frequência a depender das demandas e necessidades da família de forma periódica.

◉ 8.2 Monitoramento da rede de cuidado

Periodicidade do monitoramento: _____
Mensal, trimestral ou outra pactuada.

Serviço	Papel	Apoio ocorrendo?
ESF	Coordenação longitudinal	☐ Sim ☐ Não
eMulti/NASF	Apoio matricial	☐ Sim ☐ Não
CER	Reabilitação	☐ Sim ☐ Não
CAPSij	Saúde mental infantil	☐ Sim ☐ Não
Escola	Inclusão e socialização	☐ Sim ☐ Não
CRAS	Apoio social	☐ Sim ☐ Não
Família	Estimulação contínua	☐ Sim ☐ Não
Odontologia APS	Saúde bucal e dessensibilização oral	☐ Sim ☐ Não
Nutrição	Monitoramento alimentar e nutricional	☐ Sim ☐ Não
Neuropediatria/Pediatria do desenvolvimento	Avaliação especializada e seguimento	☐ Sim ☐ Não
Outros: _____	_____	☐ Sim ☐ Não

> Adaptar conforme disponibilidade da rede, acesso territorial e necessidades específicas da criança e da família.

✎ 9 Observações da família e da equipe

Registrar necessidades específicas, dificuldades, potencialidades e evoluções observadas.

Data do registro: _____

Participantes da reavaliação: _____

Próxima revisão

Data prevista: _____